

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa



4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 452

INFORME FINAL

17 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La **Comisión de Salud**, del Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideración e investigación de la **R. del S. 452**, presenta ante este Honorable Cuerpo su **Informe Final**, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las políticas, criterios y prácticas de las aseguradoras de salud en la Isla, relacionadas con la cobertura, reembolso o negativa a cubrir los costos asociados al uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluyendo sistemas de cirugía robótica, bandejas o equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos en procedimientos médicos; evaluar el impacto de dichas prácticas sobre el acceso a servicios de salud, la prestación de servicios médicos y los costos para pacientes, hospitales y profesionales de la salud; y examinar el marco legal y regulatorio aplicable a estas determinaciones de cobertura.

INTRODUCCIÓN

Según se desprende de la Exposición de Motivos, la Resolución del Senado 452 el acceso a servicios de salud de calidad constituye un elemento esencial para el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos en el campo de la medicina han permitido el desarrollo de nuevas modalidades

quirúrgicas que incorporan herramientas de alta precisión. Lo anterior incluye sistemas de cirugía asistida por robots, instrumentos quirúrgicos especializados y la participación de personal técnico o asistentes quirúrgicos capacitados para operar o asistir en estos procedimientos.

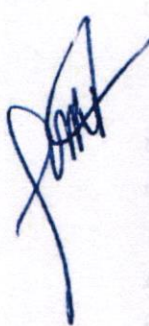
Las tecnologías que han sido adoptadas por múltiples instituciones hospitalarias y centros médicos alrededor del mundo, incluyendo en Puerto Rico, han demostrado ofrecer diversos beneficios clínicos en determinados procedimientos. Entre estos se encuentran mayor precisión quirúrgica, menor invasividad, reducción del tiempo de recuperación y, en algunos casos, mejores resultados clínicos para los pacientes. No obstante, diversos profesionales de la salud, pacientes, instituciones hospitalarias y proveedores de servicios médicos han señalado que, en ocasiones, las aseguradoras se niegan a cubrir o reembolsar determinados costos asociados a los procedimientos que utilizan tecnologías quirúrgicas avanzadas. Particularmente, las denegatorias recaen sobre procedimientos relacionados con el uso de sistemas de cirugía robótica, bandejas quirúrgicas especializadas o la participación de asistentes quirúrgicos en la sala de operaciones.

En algunos casos, los planes médicos consideran que el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas constituye únicamente una técnica adicional para realizar un procedimiento quirúrgico que ya está cubierto por el plan, por lo que no autorizan pagos adicionales asociados al uso de dichas herramientas o equipos. A su vez, la falta de uniformidad o transparencia en los criterios utilizados por los planes médicos para determinar qué componentes de un procedimiento quirúrgico son cubiertos o reembolsables, genera diferencias en el acceso de los pacientes a tecnologías médicas avanzadas.

Así las cosas, corresponde al Gobierno de Puerto Rico velar por que el sistema de prestación de servicios de salud opere de manera eficiente, transparente y en beneficio de los pacientes. En ese contexto, resulta necesario evaluar si el marco legal y regulatorio aplicable, así como las prácticas de las aseguradoras de salud, atienden adecuadamente la evolución tecnológica en la medicina moderna y si estas determinaciones de cobertura se encuentran alineadas con la política pública de acceso a servicios de salud de calidad. De igual forma, resulta pertinente examinar si las determinaciones de cobertura adoptadas por las aseguradoras responden adecuadamente a la evolución tecnológica de la medicina moderna. La incorporación de tecnologías quirúrgicas avanzadas representa

una inversión significativa para los hospitales y sistemas de salud, pero también constituye un componente cada vez más común en la práctica médica contemporánea. Ante esta realidad, el Senado de Puerto Rico entiende necesario evaluar de manera integral las políticas y prácticas de cobertura de las aseguradoras relacionadas con tecnologías quirúrgicas avanzadas y los componentes asociados a los procedimientos quirúrgicos, con el fin de identificar posibles áreas de mejora, evaluar su impacto en el sistema de salud de Puerto Rico y determinar si resulta necesario considerar medidas legislativas adicionales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA



En el ejercicio de sus facultades constitucionales de fiscalización, la Asamblea Legislativa, mediante la **Resolución del Senado 452**, encomendó a la **Comisión de Salud** del Senado de Puerto Rico llevar a cabo realizar una investigación exhaustiva sobre las políticas, criterios y prácticas de las aseguradoras de salud en la Isla, relacionadas con la cobertura, reembolso o negativa a cubrir los costos asociados al uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluyendo sistemas de cirugía robótica, bandejas o equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos en procedimientos médicos; evaluar el impacto de dichas prácticas sobre el acceso a servicios de salud, la prestación de servicios médicos y los costos para pacientes, hospitales y profesionales de la salud; y examinar el marco legal y regulatorio aplicable a estas determinaciones de cobertura.

En atención a este mandato, la Comisión procedió diligentemente a solicitar los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales. Los memoriales recibidos para realizar esta investigación fue el del Departamento de Salud de Puerto Rico (DS), Administración de Seguros de Salud (ASES), Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (ACODESE), Asociación de Hospitales, Asociación Médica, Colegio de Médicos Cirujanos, First Medical Health Plan, MCS Advantage y MMM Holdings, LLC.

Se hace constar que, de igual forma, se solicitaron los comentarios: al Plan de Salud Menonita y a Triple-S Salud, Inc. pero, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de investigación.

DEPARTAMENTO DE SALUD

Esta Comisión recibió la ponencia del **Departamento de Salud** el cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Secretario, el Dr. Victor Ramos Otero.

Expuso que la Resolución del Senado 452 tiene como propósito investigar las políticas, criterios y prácticas implementadas por las aseguradoras de salud respecto a la cobertura, reembolso o denegación de los costos relacionados con el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas, tales como la cirugía robótica, equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos. En ese sentido, sostuvo que la investigación pretende evaluar el impacto de dichas determinaciones sobre el acceso de los pacientes a los servicios de salud, la prestación de servicios médicos, los costos que enfrentan hospitales y profesionales de la salud, así como el marco jurídico y reglamentario aplicable.



Asimismo, el Departamento puntualizó que, conforme a las facultades conferidas por la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, le corresponde velar por la salud pública mediante la prevención y el control de enfermedades, así como promover las condiciones necesarias para proteger el bienestar de la población puertorriqueña. A esos efectos, enfatizó que su función principal consiste en formular e implantar políticas públicas dirigidas a garantizar la salud y la seguridad de la ciudadanía.

De igual forma, señaló que, tras consultar con la Administración de Seguros de Salud (ASES), la incorporación de nuevas tecnologías dentro de la cubierta del Plan Vital requiere estar respaldadas por evidencia científica sólida, contar con la aprobación de la *Food and Drug Administration* (FDA), sustentarse en guías clínicas reconocidas y cumplir con los criterios establecidos por los *Centers for Medicare and Medicaid Services* (CMS). Añadió, que la evaluación de estas tecnologías responde a un análisis integral que considera la viabilidad operacional del Plan Vital, las negociaciones de primas, los análisis actuariales correspondientes y la inclusión de los servicios dentro del State Plan y de la cubierta vigente. Además, precisó que aquellos tratamientos no contemplados en la cubierta pueden ser evaluados mediante el mecanismo de excepción, tomando en consideración las circunstancias clínicas particulares de cada paciente.

Finalmente, el Departamento de Salud manifestó que, en cuanto al contenido sustantivo de la Resolución del Senado 452, defería a la Administración de Seguros de Salud (ASES) la emisión de la opinión especializada, por ser la entidad responsable de implantar,

administrar y negociar los contratos con las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud al amparo de la Ley 72-1993. No obstante, reiteró su disposición de comparecer y colaborar con la Comisión durante el proceso investigativo, poniendo a su disposición la información necesaria para contribuir a una evaluación completa y fundamentada de la medida.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

Esta Comisión recibió la ponencia del **Administración de Seguros de Salud (ASES)** el cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Director Ejecutivo, Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario.

 Reconoció que las tecnologías quirúrgicas avanzadas son innovaciones han transformado la práctica médica al propiciar procedimientos menos invasivos, con mayor precisión quirúrgica y mejores resultados clínicos; sin embargo, puntualizó que existen controversias en torno a los criterios utilizados por algunas aseguradoras para determinar la cubierta de estos servicios, situación que justifica la evaluación legislativa del marco legal y reglamentario vigente.

De igual forma, indicó que cualquier incorporación de nuevas tecnologías, tratamientos o procedimientos médicos a la cubierta del Plan Vital requiere una evaluación actuarial para determinar su impacto clínico y fiscal. Añadió que, por tratarse de un programa financiado conjuntamente con fondos federales de Medicaid, toda modificación sustancial a los beneficios cubiertos exige la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) mediante un *State Plan Amendment* (SPA), proceso que requiere demostrar la viabilidad operacional y el impacto presupuestario de la iniciativa.

Referente a la cirugía robótica, la ASES manifestó que mantiene vigente la Carta Normativa 24-0829 y la Política ASES-OC-2024/P005, las cuales establecen los criterios clínicos para autorizar procedimientos asistidos por equipos o instrumentos robóticos dentro del Plan Vital. Precisó, que esta modalidad está cubierta cuando responde a una necesidad médica debidamente justificada, no representa un costo mayor al de una cirugía laparoscópica convencional y es realizada por cirujanos debidamente acreditados. Igualmente, subrayó que las determinaciones de cubierta deben sustentarse en evidencia clínica, criterios médicos aceptados y las obligaciones contractuales de las MCOs.

Finalmente, la ASES reiteró su compromiso con el acceso equitativo a servicios de salud de calidad y reconoció la importancia de las tecnologías quirúrgicas avanzadas. No obstante, advirtió que la incorporación de nuevas tecnologías que actualmente no forman parte de la cubierta del Plan Vital requiere evidencia científica robusta, aprobación de la FDA, aval del CMS y disponibilidad de fondos federales. Concluyó, que la inclusión de beneficios adicionales podría generar un impacto presupuestario significativo que el Plan Vital no está en condiciones de asumir, razón por la cual expresó su oposición a la cubierta propuesta por la Resolución del Senado 452.

OFICINA DE COMISIONADO DE SEGUROS (OCS)

Esta Comisión recibió la ponencia del **Oficina de Comisionado de Seguros (OCS)** el cual presentó su memorial explicativo por conducto de la Comisionada, Lcda. Susette Del Valle Lecároz.



La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) expresó su respaldo al propósito investigativo de la Resolución del Senado Núm. 452 y reconoció la importancia de evaluar las políticas y prácticas de los aseguradores de salud relacionadas con la cubierta, reembolso o denegación de costos asociados al uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas, tales como la cirugía robótica, equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos. Añadió, que dicha investigación permitirá determinar si el marco legal y regulatorio vigente responde adecuadamente a la evolución tecnológica de la medicina y si resulta necesario considerar medidas legislativas adicionales para garantizar un acceso equitativo a estos servicios.

Asimismo, la OCS puntualizó que, en la actualidad, diversos planes médicos comerciales en Puerto Rico ofrecen cubierta para procedimientos de cirugía asistida por tecnología robótica cuando estos constituyen una necesidad médica y no son considerados experimentales. No obstante, aclaró que la disponibilidad de dicha cubierta depende de los términos y condiciones particulares pactados en cada contrato de seguro, por lo que no existe una uniformidad entre los distintos aseguradores respecto a este beneficio.

De igual forma, expuso que, conforme a los registros de cubiertas aprobadas, algunos aseguradores cuentan con disposiciones expresas sobre cirugía robótica bajo circunstancias específicas. En ese contexto, señaló que Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista, Triple-S Salud y MCS Life Insurance Company contemplan cubiertas para determinados procedimientos mediante el Sistema Quirúrgico Da Vinci, mientras que

MAPFRE Life Insurance Company, First Medical Health Plan, Plan de Salud Menonita y Ryder Health Plan no contienen una exclusión expresa de la cirugía robótica, aunque tampoco establecen una cubierta específica para dicha tecnología.

Además, la OCS destacó que la cirugía asistida por sistemas robóticos se utiliza en una amplia variedad de especialidades médicas y añadió, que la determinación del método quirúrgico más apropiado corresponde al criterio clínico del médico tratante, en conjunto con el paciente, siempre que el procedimiento sea recomendado por un cirujano debidamente cualificado y capacitado en dicha técnica.

Por otra parte, la Oficina informó que no identificó legislación estatal en los Estados Unidos que imponga un mandato específico de cubierta obligatoria para procedimientos de cirugía robótica. En consecuencia, explicó que la determinación sobre la cubierta continúa rigiéndose por las disposiciones contractuales, los criterios de necesidad médica y las condiciones económicas aplicables, incluyendo copagos y deducibles.

Finalmente, la OCS reconoció que la cirugía asistida por tecnología robótica ofrece beneficios clínicos significativos, entre ellos una mayor precisión quirúrgica, menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, lo que redundaría en una mejor calidad de vida para los pacientes. Sin embargo, recomendó que, previo a considerar un mandato legislativo de cubierta obligatoria, la Comisión promueva estudios actuariales para evaluar el impacto económico de la medida sobre la sostenibilidad del sistema y sus efectos en las primas, copagos y deducibles. Asimismo, manifestó deferencia al criterio técnico que puedan emitir el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del Procurador del Paciente.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO

Esta Comisión recibió la ponencia del **Asociación de Hospitales de Puerto** de su Presidente, Lcdo. Jaime Plá Cortés. Expuso que respalda la aprobación de la Resolución del Senado 452, al entender que resulta necesario realizar una investigación amplia, objetiva y basada en evidencia sobre las políticas, criterios y prácticas de las aseguradoras de salud relacionadas con la cobertura, el reembolso y las determinaciones de pago de tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluyendo los sistemas de cirugía robótica, equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos.

Asimismo, señaló que la Asociación representa a la mayoría de los hospitales públicos y privados de Puerto Rico, así como a diversas instituciones y entidades vinculadas a la prestación de servicios de salud, cuya misión ha sido promover la excelencia en el sistema hospitalario del País. En ese contexto, puntualizó que la evolución de la medicina ha permitido incorporar tecnologías innovadoras que aumentan la precisión de los procedimientos quirúrgicos, favorecen una recuperación más rápida de los pacientes y amplían las alternativas terapéuticas disponibles para la comunidad médica.

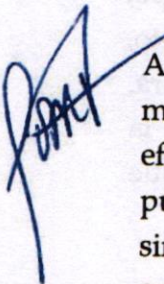
No obstante, advirtió que la implementación de estas tecnologías también ha generado desafíos significativos en cuanto a los mecanismos de autorización, cobertura y reembolso utilizados por las aseguradoras, lo que incide directamente sobre la capacidad de los hospitales para ofrecer estos servicios de manera sostenible. Añadió, que las instituciones hospitalarias realizan inversiones sustanciales para adquirir, mantener y actualizar equipos de alta tecnología, desarrollar la infraestructura necesaria y capacitar al personal clínico especializado, con el propósito de garantizar que los pacientes tengan acceso a tratamientos modernos y de alta calidad.

De igual forma, la Asociación de Hospitales sostuvo, que resulta pertinente que la Asamblea Legislativa evalúe si las políticas actuales de cobertura y reembolso responden adecuadamente a la realidad clínica y tecnológica del sistema de salud, así como al impacto que dichas determinaciones tienen sobre los pacientes, los hospitales, los médicos y los demás profesionales de la salud. En ese sentido, planteó que una evaluación integral permitirá identificar, mediante evidencia objetiva, aquellas áreas regulatorias, operacionales y de política pública susceptibles de fortalecimiento, procurando un balance entre el acceso de los pacientes a tecnologías médicas avanzadas, la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el uso responsable de los recursos disponibles.

Finalmente, enfatizó que el proceso investigativo debe incorporar la participación de todos los sectores involucrados, incluyendo hospitales, profesionales de la salud, pacientes, aseguradoras, agencias reguladoras y organizaciones especializadas, a fin de que cualquier recomendación legislativa responda a un análisis multidisciplinario y completo. Concluyó, reiterando su plena disposición para colaborar con la Comisión de Salud del Senado, aportando su experiencia, datos e información técnica que contribuyan al desarrollo de una investigación objetiva y al fortalecimiento del sistema de salud en beneficio de los pacientes y de la prestación de servicios médicos de excelencia.

ASOCIACIÓN MÉDICA DE PUERTO RICO

Esta Comisión recibió la ponencia del **Asociación Médica de Puerto Rico** la cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Dr. Edgardo N. Rosario Burgos. En la misma planteó que la Resolución del Senado 452 constituye una oportunidad para examinar de manera integral las políticas de cobertura, reembolso y denegación relacionadas con tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluyendo la cirugía robótica, el instrumental especializado y la participación de asistentes quirúrgicos. Reconoció, que la innovación tecnológica ha transformado significativamente la práctica médica al mejorar los resultados clínicos, reducir complicaciones y favorecer la recuperación de los pacientes; sin embargo, advirtió que su incorporación al sistema de salud debe atender también consideraciones financieras, regulatorias y éticas que aseguren la sostenibilidad del sistema.



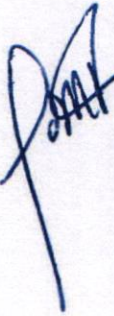
Asimismo, puntualizó que toda política pública dirigida a ampliar el acceso a tecnologías médicas debe armonizar la evidencia científica, la seguridad del paciente, la costo-efectividad y el impacto presupuestario. Sostuvo, que las decisiones sobre cobertura no pueden responder exclusivamente al costo económico ni a la disponibilidad tecnológica, sino que deben fundamentarse en criterios objetivos, transparentes y uniformes que garanticen certeza a pacientes, profesionales de la salud, hospitales y aseguradoras. Igualmente, subrayó que cualquier legislación que imponga nuevas obligaciones de cobertura debe estar respaldada por un análisis actuarial y financiero independiente que identifique una fuente permanente de financiamiento.

De igual forma, la Asociación Médica expuso que el acceso a servicios de salud constituye un objetivo esencial de política pública; no obstante, señaló que ningún sistema sanitario dispone de recursos ilimitados, razón por la cual resulta indispensable aplicar principios de economía de la salud que permitan asignar los recursos de manera eficiente y responsable. Explicó, que toda expansión de beneficios implica un costo de oportunidad, pues los recursos destinados a una nueva tecnología dejan de estar disponibles para financiar otros servicios igualmente prioritarios. En consecuencia, reiteró que la creación de nuevas cubiertas sin respaldo financiero podría traducirse en aumentos en las primas, restricciones administrativas, reducción de beneficios y presiones económicas sobre hospitales y proveedores.

Por otro lado, la Asociación destacó que la evaluación de tecnologías sanitarias constituye el estándar internacional para determinar la incorporación de innovaciones médicas al

sistema de salud. Explicó, que dicho proceso examina la eficacia, seguridad, costo-efectividad e impacto presupuestario, entre otros criterios, y propuso que Puerto Rico adopte un modelo permanente de cobertura basada en evidencia científica mediante evaluaciones técnicas independientes y transparentes.

En cuanto a las tecnologías quirúrgicas avanzadas, manifestó que la cirugía robótica constituye una herramienta cuyo valor clínico depende del procedimiento realizado, la condición del paciente, la experiencia del equipo quirúrgico y la infraestructura hospitalaria. Indicó, que la literatura científica demuestra beneficios potenciales en determinados procedimientos, aunque aclaró que estos no son uniformes y que las decisiones de cobertura deben realizarse conforme a la evidencia científica disponible.



Igualmente, señaló, que el análisis económico no debe limitarse al costo inicial del equipo, sino considerar el costo total del proceso asistencial, incluyendo mantenimiento, actualización tecnológica, instrumental especializado, capacitación e infraestructura. Agregó, que determinadas tecnologías pueden generar ahorros futuros mediante la reducción de complicaciones, readmisiones y tiempo de hospitalización, siempre que tales beneficios sean demostrados científicamente.

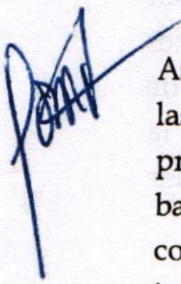
Respecto a las bandejas especializadas y los asistentes quirúrgicos, reconoció que en numerosos procedimientos constituyen componentes esenciales para la seguridad del paciente y la eficiencia operatoria. No obstante, puntualizó que su utilización debe evaluarse mediante criterios clínicos objetivos y recomendó diferenciar aquellos procedimientos donde estos recursos constituyen un estándar de atención de aquellos en que la evidencia aún resulta insuficiente.

Finalmente, la Asociación Médica concluyó que la controversia planteada por la Resolución del Senado 452 representa una oportunidad para que Puerto Rico establezca un modelo moderno de incorporación de tecnologías sanitarias basado en evidencia científica, análisis económico, estudios actuariales y responsabilidad fiscal. En consecuencia, recomendó que toda medida legislativa que cree nuevas obligaciones permanentes de cobertura, esté precedida por un Informe de Impacto Económico y Presupuestario en Salud, reafirmando que las decisiones sobre nuevas tecnologías deben adoptarse mediante procesos objetivos, transparentes y financieramente sostenibles.

COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS

Esta Comisión recibió la ponencia del **Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico** el cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Dr. Carlos Díaz Vélez.

Expresó su firme respaldo a la Resolución del Senado 452 al entender que la investigación propuesta resulta indispensable para evaluar las políticas, criterios y prácticas de las aseguradoras de salud relacionadas con la cobertura, el reembolso y las denegatorias de tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluyendo los sistemas de cirugía robótica, equipos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos. Sostuvo que este proceso investigativo permitirá armonizar el sistema de salud de Puerto Rico con los estándares internacionales de la medicina contemporánea y garantizar un acceso equitativo a tratamientos quirúrgicos de mayor calidad.



Asimismo, el Colegio puntualizó que la evolución de la medicina moderna ha convertido las tecnologías quirúrgicas de alta precisión en el estándar de atención para múltiples procedimientos complejos, tales como cirugías oncológicas, urológicas, ginecológicas, bariátricas y abdominales. Expuso, que la evidencia científica demuestra consistentemente que estas tecnologías ofrecen mayor precisión quirúrgica, menor invasividad, reducción de pérdidas sanguíneas, menos complicaciones postoperatorias, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida, lo que redundará en una mejor calidad de vida para los pacientes, especialmente aquellos con múltiples comorbilidades.

De igual forma, señaló, que las denegatorias sistemáticas de cobertura por parte de las aseguradoras, al catalogar estas tecnologías como procedimientos adicionales sin reembolso correspondiente, generan consecuencias adversas para el sistema de salud. Indicó, que dicha práctica desalienta la inversión hospitalaria en equipos de vanguardia, limita el desarrollo y adiestramiento de cirujanos especializados, fragmenta la continuidad del cuidado y obliga a numerosos pacientes a someterse a procedimientos más invasivos, incrementando el riesgo de complicaciones, infecciones, dolor prolongado y ausentismo laboral. Añadió, que esta realidad profundiza las desigualdades en el acceso a tratamientos avanzados, ya que únicamente quienes poseen capacidad económica pueden asumir los costos de estas intervenciones.

Por otra parte, el Colegio de Médicos Cirujanos argumentó que, aunque la cirugía robótica representa una inversión inicial superior, diversos estudios de costo-efectividad evidencian que los beneficios económicos a mediano y largo plazo compensan dicho gasto. Precisó, que la reducción en hospitalizaciones, readmisiones, reintervenciones y complicaciones, así como la reincorporación temprana de los pacientes a sus actividades productivas, disminuyen significativamente el costo total del episodio de atención médica. Añadió, que estos beneficios adquieren mayor relevancia en pacientes con enfermedades crónicas y condiciones complejas, donde las ganancias clínicas y económicas son aún más evidentes.



En ese contexto, destacó que Puerto Rico enfrenta una realidad particularmente preocupante debido a la elevada prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Sostuvo que, ante este panorama epidemiológico, las tecnologías quirúrgicas avanzadas constituyen herramientas esenciales para reducir riesgos perioperatorios, mejorar los resultados clínicos y disminuir las complicaciones que incrementan los costos del sistema de salud. Alertó, que las actuales denegatorias de cobertura amplían la brecha en el acceso a servicios especializados, fomentan la migración del talento médico y limitan la capacidad del sistema de ofrecer un estándar de atención equiparable al de otras jurisdicciones.

Finalmente, el Colegio de Médicos Cirujanos planteó que la experiencia de otras jurisdicciones demuestra que los modelos regulatorios que reconocen el valor clínico y económico de estas tecnologías han promovido una integración responsable de la cirugía robótica, mejorando simultáneamente la calidad y eficiencia de los sistemas de salud. En consecuencia, instó a la Comisión de Salud del Senado a continuar la investigación ordenada por la Resolución del Senado 452, incorporando evidencia científica, evaluando comparativamente las prácticas de las aseguradoras y considerando alternativas regulatorias que fortalezcan la transparencia, la uniformidad y el acceso a servicios de salud de excelencia. Concluyó, reiterando su disposición para colaborar con datos clínicos, evidencia científica y el testimonio de especialistas, al entender que el seguimiento a esta resolución representa un paso decisivo hacia un sistema de salud más moderno, eficiente, equitativo y centrado en el bienestar de los pacientes.

ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS (ACODESE)

Esta Comisión recibió la ponencia del Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) el cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidenta, Lcda. Israelia Pernas.

Reconoció la importancia de la Resolución del Senado 452 y la pertinencia de examinar las políticas de cubierta relacionadas con el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas. No obstante, puntualizó, que la incorporación de innovaciones como la cirugía robótica ha ampliado las alternativas terapéuticas disponibles y puede generar beneficios clínicos para determinados pacientes; sin embargo, sostuvo que la utilización de una tecnología específica no crea, por sí misma, una obligación uniforme para que todos los planes médicos cubran o reembolsen los costos asociados a su utilización.



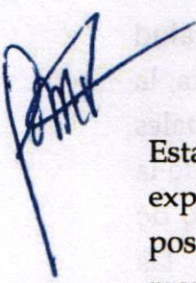
Asimismo, expuso que las determinaciones de cubierta en los seguros de salud responden a diversos factores, entre ellos los términos y condiciones de cada póliza, la evaluación de necesidad médica, las políticas de utilización y los acuerdos contractuales entre aseguradores y proveedores de servicios de salud. En ese contexto, señaló que la cubierta de un procedimiento y el reconocimiento de pagos adicionales por el uso de determinada tecnología deben evaluarse conforme al contrato aplicable y a las circunstancias particulares de cada caso, descartando que exista un derecho automático a reembolsos adicionales por el empleo de equipos robóticos, bandejas quirúrgicas especializadas o asistentes quirúrgicos.

De igual forma, planteó que resulta indispensable distinguir entre el procedimiento médico cubierto y la técnica utilizada para realizarlo. Indicó, que un procedimiento puede estar cubierto independientemente de si se practica mediante cirugía abierta, laparoscópica o robótica, por lo que la selección de una modalidad tecnológica no implica necesariamente que deba reconocerse un pago adicional. Agregó, que estas determinaciones obedecen a los criterios clínicos, administrativos y contractuales que rigen cada plan de salud.

De otra parte, reconoció que las tecnologías quirúrgicas avanzadas representan un importante adelanto para la práctica médica, al ofrecer beneficios como una mayor precisión quirúrgica, mejor visualización del campo operatorio, incisiones menos invasivas, menor pérdida de sangre y una recuperación más rápida en determinados pacientes. No obstante, advirtió que dichas tecnologías también conllevan costos

significativamente superiores a los de las técnicas convencionales, incluyendo la adquisición y mantenimiento de los sistemas robóticos, los instrumentos especializados, el entrenamiento del personal médico y clínico, así como otros gastos operacionales inherentes a su utilización.

Finalmente, enfatizó, que cualquier propuesta dirigida a convertir estos costos en cubiertas mandatorias debe fundamentarse en un análisis riguroso de la evidencia clínica, la costo-efectividad y el impacto actuarial y financiero sobre el sistema de salud. En ese sentido, advirtió que imponer beneficios obligatorios sin una evaluación integral podría incrementar el costo de las reclamaciones y, consecuentemente, elevar las primas que pagan patronos, individuos y familias, afectando la asequibilidad de la cobertura y el acceso de la ciudadanía a los servicios de salud. Por ello, concluyó que toda ampliación de las cubiertas debe responder a criterios técnicos y financieros que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguros de salud.



MCS ADVANTAGE

Esta Comisión examinó la ponencia de **MCS Advantage** el cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Roberto G. Pando Cintrón, notificando que su posición oficial respecto a la Resolución del Senado 452 será presentada a través del memorial que someterá la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE). La entidad optó por adoptar y hacer referencia a los planteamientos, argumentos y recomendaciones expuestos por dicha asociación, evidenciando que su postura institucional se encuentra alineada con la presentada por ACODESE para la consideración de la medida investigativa

FIRST MEDICAL HEALTH PLAN

Esta Comisión recibió la ponencia de **First Medical Health Plan** el cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Chief Legal, Carlos Santana.

First Medical Health Plan expuso que, en relación con los asuntos sometidos ante la consideración de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, acostumbra a canalizar sus comentarios y posiciones institucionales a través de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), con el propósito de presentar una postura representativa y consensuada del sector asegurador. De igual forma, señaló que agradece la oportunidad brindada por la Comisión para participar en el proceso legislativo y

reiteró su disposición para atender cualquier requerimiento adicional o solicitud de información que fuese necesaria.

MMM HOLDINGS, LLC. y MMM MULTIHEALTH, LLC.

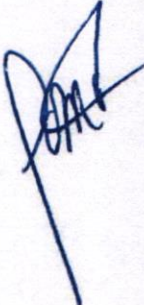
Esta Comisión recibió el Memorial Explicativo de **MMM Holdings, LLC. y MMM Multihealth, LLC. (MMM)** suscrito por su Director Senior, Jonathan A. Bonett Rivera.

Manifestaron su respaldo a la investigación propuesta mediante la Resolución del Senado 452 y reconocieron la importancia de evaluar las políticas de cobertura relacionadas con las tecnologías quirúrgicas avanzadas, al entender que el acceso oportuno a tratamientos innovadores y el respeto al criterio clínico constituyen elementos esenciales para garantizar una atención médica segura, eficiente y de alta calidad. En ese contexto, puntualizaron que la investigación representa una oportunidad para armonizar el acceso a dichas tecnologías con la protección de los pacientes, el marco regulatorio vigente y la sostenibilidad del sistema de salud, favoreciendo el uso de tratamientos respaldados por evidencia científica y las correspondientes aprobaciones regulatorias.

Asimismo, expusieron que, como entidad administradora de servicios de salud bajo el Programa Medicaid a través del Plan Vital, MMM mantiene un compromiso con la prestación de servicios de excelencia y resaltó que la Administración de Seguros de Salud (ASES) posee la información clínica, operacional y financiera necesaria para evaluar el impacto que tendría cualquier ampliación de cubiertas. En consecuencia, indicaron que deferían a la posición técnica y actuarial de ASES respecto al efecto económico y de prestación de servicios que pudiera derivarse de las medidas contempladas en la Resolución para el Plan Vital.

De igual forma, plantearon que la aplicación de la Resolución presenta importantes limitaciones respecto al programa federal Medicare Advantage, debido a que este opera bajo un marco jurídico exclusivamente federal. Sostuvieron que las cubiertas y beneficios de dicho programa son determinados por legislación y reglamentación federal administrada por los *Centers for Medicare & Medicaid Services* (CMS), por lo que las iniciativas legislativas estatales no pueden imponer requisitos adicionales sobre las organizaciones Medicare Advantage, salvo en materias relacionadas con licenciamiento y solvencia. A esos efectos, fundamentaron su posición en las disposiciones de la Ley Federal de Seguro Social, el *Medicare Modernization Act* y diversa jurisprudencia federal que reconoce la doctrina de ocupación de campo (*federal preemption*) en esta materia.

Señalaron, que CMS regula de forma integral los criterios para determinar la cubierta de procedimientos quirúrgicos y que actualmente no existe una política nacional que autorice o prohíba de manera general el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas como un beneficio independiente dentro de Medicare. Explicaron, que la determinación de cubierta responde al criterio de que el procedimiento sea razonable y médicamente necesario, independientemente de si se realiza mediante cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Del mismo modo, precisaron que los sistemas de cirugía robótica son considerados equipo del hospital y que su utilización, por sí sola, no genera un reembolso adicional, mientras que la compensación por asistentes quirúrgicos depende del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, necesidad médica y correcta facturación establecidos por CMS.



Finalmente, recomendaron que la investigación legislativa examine con detenimiento el impacto financiero que la posible ampliación de cubiertas tendría sobre el Plan Vital; el papel del criterio clínico de los profesionales de la salud para justificar el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas; los riesgos asociados a la sobreutilización de equipos de alto costo y la posible duplicidad de cargos; así como la necesidad de definir con mayor precisión las responsabilidades del Departamento de Salud, ASES y las agencias reguladoras en la autorización, fiscalización y cumplimiento de los criterios aplicables. Concluyeron reiterando su compromiso con el acceso a servicios de salud de alta calidad, particularmente para las poblaciones más vulnerables, y su disposición para continuar colaborando con la Comisión durante el proceso investigativo.

HALLAZGOS

Con base en la Exposición de Motivos y en el análisis integral de los memoriales presentados por las agencias gubernamentales, organismos reguladores, entidades hospitalarias, asociaciones médicas y representantes del sector asegurador, esta Comisión concluye que la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 452 evidenció la existencia de una controversia legítima de política pública relacionada con la incorporación de tecnologías quirúrgicas avanzadas dentro del sistema de prestación de servicios de salud en Puerto Rico. La evidencia recopilada demuestra que el desarrollo tecnológico de la medicina contemporánea ha superado, en múltiples aspectos, la evolución de los criterios administrativos y contractuales utilizados por algunos aseguradores para determinar la cubierta y el reembolso de dichos procedimientos,

circunstancia que justifica el ejercicio de la facultad investigativa de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, los memoriales coinciden en reconocer que tecnologías como la cirugía robótica, los equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos constituyen herramientas que, en procedimientos clínicamente indicados, pueden contribuir a una mayor precisión operatoria, reducir complicaciones, disminuir el tiempo de hospitalización y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes. No obstante, también quedó demostrado que tales beneficios no eliminan la necesidad de que toda determinación sobre su incorporación a las cubiertas de los planes médicos descansa sobre evidencia científica robusta, evaluaciones de costo-efectividad, análisis actuariales y estudios de impacto presupuestario que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de salud.



La investigación igualmente permitió constatar que no existe uniformidad entre las aseguradoras respecto a los criterios utilizados para autorizar o reembolsar los costos asociados a estas tecnologías. Mientras algunos planes contemplan expresamente determinadas modalidades de cirugía robótica bajo criterios específicos de necesidad médica, otros limitan dichas determinaciones a las condiciones particulares de cada contrato o consideran que la tecnología utilizada constituye únicamente una modalidad técnica para ejecutar un procedimiento previamente cubierto, sin que ello genere un derecho automático a pagos adicionales. Esta diversidad de criterios evidencia la ausencia de parámetros uniformes que promuevan mayor transparencia y previsibilidad para pacientes, médicos, hospitales y demás componentes del sistema sanitario.

De una parte, el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del Comisionado de Seguros coincidieron en que cualquier modificación a las cubiertas del Plan Vital o de otros programas financiados con fondos federales debe observar los requisitos regulatorios, los análisis actuariales y la viabilidad presupuestaria correspondiente. En consecuencia, quedó acreditado que la incorporación de nuevas tecnologías exige armonizar la evidencia científica con las limitaciones jurídicas, fiscales y operacionales aplicables.

Mientras que la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico y el Colegio de Médicos Cirujanos coincidieron en que las actuales prácticas de cobertura pueden afectar la inversión hospitalaria en infraestructura tecnológica, el

desarrollo de personal especializado y el acceso oportuno de los pacientes a tratamientos innovadores. A juicio de estas entidades, la incertidumbre sobre los mecanismos de reembolso puede limitar la modernización del sistema de salud y la competitividad de Puerto Rico en la prestación de servicios altamente especializados.

Por su parte, las entidades representativas del sector asegurador, incluyendo ACODESE, MMM Holdings, MCS Advantage y First Medical Health Plan, reconocieron la importancia de examinar las políticas de cubierta, aunque sostuvieron que las decisiones deben fundamentarse en la necesidad médica, la evidencia científica, las disposiciones contractuales y la sostenibilidad financiera del sistema. Advirtieron, además, que la creación de cubiertas mandatorias sin estudios técnicos podría repercutir sobre el costo de las primas y el equilibrio económico del mercado de seguros de salud.



Del análisis comparativo de los memoriales surge un consenso respecto a la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias mediante criterios objetivos, transparentes y uniformes. Aunque existen diferencias sobre la conveniencia de imponer nuevas obligaciones de cubierta, la mayoría de los deponentes coincidió en que cualquier determinación futura debe sustentarse en evidencia científica, evaluaciones económicas independientes y mecanismos regulatorios que armonicen el acceso de los pacientes con la utilización responsable de los recursos públicos y privados.

Finalmente, esta Comisión concluye que la investigación cumplió el propósito consignado en la Exposición de Motivos al recopilar información técnica, clínica, jurídica, regulatoria y financiera suficiente para identificar las principales áreas de controversia relacionadas con las tecnologías quirúrgicas avanzadas. Los memoriales examinados demuestran que el asunto trasciende una discusión contractual entre aseguradoras y proveedores, pues involucra el acceso equitativo de los pacientes a tratamientos innovadores, la sostenibilidad del sistema de salud y la necesidad de que cualquier futura intervención legislativa responda a un proceso de evaluación multidisciplinario, fundamentado en evidencia científica y compatible con el marco regulatorio vigente.

RECOMENDACIONES

Esta Comisión recomienda que el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Oficina del Comisionado de Seguros y las demás entidades con competencia regulatoria continúen desarrollando mecanismos de coordinación interagencial que permitan evaluar de manera periódica la incorporación de tecnologías

quirúrgicas avanzadas, tomando como base la mejor evidencia científica disponible, las guías clínicas reconocidas, los criterios regulatorios federales y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Se recomienda promover la adopción de criterios objetivos, uniformes y transparentes para la evaluación de solicitudes de cubierta y reembolso relacionadas con cirugía robótica, equipos quirúrgicos especializados y asistentes quirúrgicos, procurando reducir disparidades entre aseguradoras y fortalecer la certeza jurídica de pacientes, hospitales y profesionales de la salud, sin menoscabar las obligaciones contractuales ni el criterio de necesidad médica.

Esta Comisión estima pertinente que toda propuesta legislativa o reglamentaria dirigida a ampliar cubiertas obligatorias esté precedida por estudios actuariales, análisis de impacto económico y evaluaciones de tecnologías sanitarias independientes que examinen la eficacia clínica, la costo-efectividad, el impacto presupuestario y la viabilidad operacional de las medidas consideradas.

Asimismo, se recomienda fomentar espacios permanentes de colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico, las aseguradoras, los hospitales, las asociaciones médicas y demás organizaciones especializadas, con el propósito de intercambiar información técnica y desarrollar políticas públicas sustentadas en consenso y evidencia científica.

De igual forma, resulta aconsejable fortalecer los procesos de recopilación y análisis de datos relacionados con autorizaciones, denegatorias, reembolsos y utilización de tecnologías quirúrgicas avanzadas, a fin de identificar tendencias, evaluar su impacto sobre el acceso a servicios de salud y facilitar futuras determinaciones legislativas y administrativas basadas en información objetiva.

Esta Comisión recomienda que cualquier revisión futura del marco legal preserve un adecuado balance entre la innovación tecnológica, el acceso equitativo de los pacientes a tratamientos de alta complejidad, la autonomía del criterio clínico de los profesionales de la salud y la estabilidad financiera de los programas públicos y privados de aseguramiento médico.

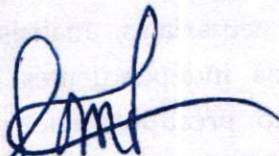
Finalmente, la Comisión recomienda mantener un proceso continuo de fiscalización legislativa sobre la evolución de las políticas de cubierta relacionadas con tecnologías quirúrgicas avanzadas, requiriendo la comparecencia de las agencias reguladoras y de los sectores concernidos cuando resulte necesario, con el propósito de asegurar que las

determinaciones administrativas continúen respondiendo al interés público, a la evidencia científica y a las necesidades cambiantes del sistema de salud de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo su **Informe Final** sobre la **Resolución del Senado 452**, con los hallazgos y recomendaciones para su consideración

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez

Presidente

Comisión de Salud